

Cours : Facteurs de risque, Prévention et Dépistage des cancers

Objectifs pédagogiques

- Comprendre les notions de prévention primaire, secondaire et tertiaire.
- Identifier les principaux facteurs de risque des cancers.
- Connaître les principes et critères d'un dépistage efficace.
- Saisir l'importance du dépistage organisé dans la réduction de la mortalité.

Plan du cours

1. Préambule
2. La prévention des cancers
3. Facteurs de risque : endogènes et exogènes
4. Lutte anti-tabac
5. Le dépistage : définitions et types
6. Évaluation d'un test de dépistage
7. Critères OMS du dépistage organisé
8. Dépistages ayant démontré une diminution de la mortalité
10. Conclusion

Contenu du cours

1. PREAMBULE

Le cancer représente un phénomène tout à fait particulier dans le domaine de la santé.

Le nombre de patients atteints de cancer continue d'augmenter de manière constante.

En Algérie, les registres du cancer reconnus par les instances internationales, confirment cette tendance

Au-delà de ces chiffres, le cancer représente surtout une charge particulièrement lourde parce qu'il entraîne plus de souffrances et de drames que n'importe quelle autre maladie sur le plan personnel et familial en plus de la charge financière particulièrement élevée.

La plupart des cancers sont malheureusement diagnostiqués à un stade tardif, et dont la prise en charge implique un coût non négligeable.

Le dépistage et la prévention permettraient d'éviter et de diagnostiquer à un stade précoce certains cancers.

2. LA PREVENTION

Ensemble des moyens susceptibles d'empêcher l'apparition d'une maladie

2.1 PREVENTION PRIMAIRE:

Suppression de l'exposition aux facteurs de risque, avant l'apparition de la maladie

Elle implique de nombreux intervenants avec en premier lieu les pouvoirs publics et les personnels de santé.

2.2 PREVENTION SECONDAIRE:

Dépistage d'une lésion précancéreuse ou d'un cancer localisé pour permettre un traitement curatif.

2.3 PREVENTION TERTIAIRE:

Prévention des complications de la maladie une fois installée.

PREVENTION PRIMAIRE	✓ Lutte anti tabac ✓ Lutte anti alcool ✓ Education en faveur d'une alimentation équilibrée ✓ Lutte contre l'exposition solaire ✓ Lutte contre les FDR professionnels (médecine du travail) ✓ Vaccination contre le HPV ✓ Vaccination contre le VHB
PREVENTION SECONDAIRE	✓ Dépistage organisé du kc du sein ✓ Dépistage du kc colo rectal ✓ Dépistage du kc du col utérin ✓ Dépistage du kc de la prostate ✓ Dépistage du mélanome
PREVENTION TERTIAIRE	Selon le cancer

NB : FDR non modifiables à l'état de connaissance actuel :

FDR génétiques

Le vieillissement

Un terrain hormonal endogène

4.Lutte anti tabac

90% des KC bronchique sont liés au tabac, ainsi que :le KC de la vessie, de l'estomac ,du Col utérin, des lèvres ,certains KC ORL

La consommation de tabac en Algérie a triplé ces trois dernières décennies et la tendance est au maintien de cette évolution. La lutte contre le tabagisme est plus que jamais une priorité. Le plan de lutte contre le tabagisme doit s'inscrire dans la durée et être appliqué de manière constante et rigoureuse.

5.DEPISTAGE :

Définition: Identification ,a l'aide d'un test ,des sujets atteints par une maladie avant qu'elle ne devienne symptomatique.

C'est l'examen d'individus asymptomatiques pour déterminer leur probabilité d'avoir la maladie.

Les personnes dont la probabilité d'être atteints par la pathologie est suffisamment élevée sont ensuite soumis à des investigations diagnostiques

Le but du dépistage est de permettre le diagnostic à un stade précoce d'un cancer asymptomatique qui, s'il n'était pas traité, entraînerait la survenue de symptômes ou le décès.

TYPES DE DEPISTAGE:

-Dépistage de masse :

Proposé à la population générale définie seulement en termes de sexe et d'âge, sans symptôme ni facteur de risque particulier.....à l'initiative des pouvoirs publics.

-Dépistage individuel:

chez les sujets ayant des facteurs de risques.... à l'initiative du médecin

-Dépistage dans une population à risque : Dépistage ciblé

Peut s'appliquer aux patients présentant ATCD familiaux de cancers ; ces patients particuliers bénéficient d'un dépistage ciblé, comme par exemple:

Une IRM mammaire et non mammographie chez les femmes avec mutations de BRCA....

6. EVALUATION D'UN TEST DE DÉPISTAGE

6.1 LES CRITÈRES

TEST:

-Peu coûteux

-Simple, facile à réaliser

- Acceptable par la population
- Sensible(peu de faux négatifs)
- Reproductible
- Réalisable en toute innocuité

MALADIE:

- Fréquente
- Grave
- Problème de sante publique
- Période asymptomatique longue
- Histoire naturelle connue
- Existence d'un traitement améliorant la morbi-mortalité
- Délectable a un stade précoce

Population cible:

- Ayant accès au dépistage
- Acceptant le dépistage
- Données démographiques connues

Existence d'un réseau de soin permettant la prise en charge des personnes dépistées

Le cancer se prête parfaitement au dépistage car il regroupe l'ensemble de ses conditions

6.2 INDICATEURS D'UN TEST DE DEPISTAGE :

a-Indicateurs de qualité

1. Sensibilité : Capacité à détecter les sujets malades.
2. Spécificité : Capacité à repérer les sujets sains .
3. Valeur prédictive positive (vpp) : Probabilité d'avoir la maladie quand le test est positif (nb de tests positifs/nb total d'examen positif).
4. Valeur prédictive négative (vpn) : Probabilité de ne pas avoir la maladie quand le test est négatif (nb de tests négatifs/nb tot d'ex négatifs).

NB : Pour un test de dépistage la sensibilité est privilégiée ; on fait un test sensibilité↑;suivis d'un test de confirmation (spécificité ↑)

Exp: hémoculture (dépistage)→colono (dgc)

b.Les indicateurs d'impact :

- 1.Taux de participation.
- 2.Taux de couverture.
- 3.Taux de fidélisation..

c.Les indicateurs d'efficacité :

Dépend du taux et du type de cancer détecté.

7. LES 10 CRITÈRES OMS DU DÉPISTAGE ORGANISÉ

1. La maladie dépistée doit constituer une menace grave pour la santé publique (fréquence de la pathologie, gravité des cas...)
2. Il doit exister un traitement d'efficacité démontrée
3. Il faut disposer de moyens appropriés de diagnostic et de traitement
4. La maladie doit être décelable pendant une phase de latence ou au début de la phase clinique
5. Il existe un examen de dépistage efficace (fiable, reproductible)
6. Il faut que l'épreuve utilisée soit acceptable pour la population
7. Il faut bien connaître l'histoire naturelle de la maladie
8. Il faut que le choix des sujets qui recevront un traitement soit précisé selon des critères préétablis
9. Il faut que le coût de la recherche des cas ne soit pas disproportionné par rapport au coût global des soins médicaux
10. Il faut assurer la continuité d'actions dans la recherche des cas et non la considérer comme une opération exécutée « une fois pour toutes »

8. Les dépistages ayant démontré une diminution de la mortalité...

- Cancer du col de l'utérus : Un frottis de dépistage réalisé tous les 3 ans réduit de plus de 90 % la mortalité cumulée entre 35 et 65 ans par cancer du col de l'utérus.
- Cancer du sein : Une mammographie de dépistage à partir de 50 ans réduit de 25 à 30 % la mortalité par cancer du sein.
- Cancer colorectal : La pratique d'un examen des selles à la recherche de pertes sanguines par la méthode immunologique réduit de 15 % la mortalité par cancer colorectal

Certains facteurs peuvent contribuer à réduire le risque de cancers...

Tableau tiré du rapport de l'INCa "Nutrition et prévention primaire des cancers : actualisation des données"

PREVENTION PRIMAIRE	PREVENTION SECONDAIRE
✓ Ne pas fumer ✓ Lutter contre la consommation d'alcool ✓ Eviter l'exposition solaire prolongée ✓ Respecter les consignes de sécurité ✓ Consommer régulièrement fruits et légumes ✓ Aliments riches en fibres	✓ Frottis CV régulier ✓ Auto palpation +ex régulier des seins +mammographie après 50 ans ✓ Consulter le médecin si: • Un noevus change d'aspect • Une perte de sang anormale • Toux persistante • Voix rauque • Modification de l'aspect des selles • AMG inexpliqué • Apparition d'une nodosité cutanée

9. Conclusion

La prévention et le dépistage représentent un pilier important dans la lutte contre le cancer ;et restent à ce jour le seul vrai traitement du cancer.

Le développement de la biologie moléculaire doit induire une augmentation de la sensibilité et de la spécificité des tests de dépistage et de l'identification des sujets a haut risque dans la population asymptomatique.